BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

QUY TRÌNH
HỌP HỘI ĐỒNG NGƯỜI BỆNH
Số: 01/ QT-PĐD

Trách nhiệm	Soạn thảo	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ và tên	**CKIĐD. Võ Hồng Thái**	**CKIĐD. Võ Hồng Thái**	**TSBS. Châu Hữu Hầu**
Chữ ký			
Chức vụ	**Trưởng phòng Phòng Điều dưỡng**	**Trưởng phòng Phòng Điều dưỡng**	**Giám đốc**

Bản nguồn: ngày ban hành 02/01/2026
Bản cập nhật trình thẩm định: 13/10/2026
Ngày hiệu lực bản cập nhật: ……/……/……

Lần ban hành bản nguồn: 01 — phiên bản cập nhật chờ phê duyệt

NƠI NHẬN *(ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ô bên cạnh)*

☑	Giám đốc	☐		☐	
☑	Phó giám đốc	☐		☐	
☑	Phòng KHTH	☐		☐	
☑	Tổ QLCLBV	☐		☐	
☑	Các Khoa lâm sàng	☐		☐	

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (*tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)*

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
Theo nội	Lịch họp và theo dõi kiến nghị	13/10/2026: cấp khoa hằng tuần; chọn Chủ tịch theo ý kiến đa số; bổ sung

1. MỤC ĐÍCH

Hội đồng người bệnh là một hình thức phát huy quyền làm chủ của người bệnh trong việc đóng góp về khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc phục vụ người bệnh và vận động người bệnh có trách nhiệm thực hiện quy chế bệnh viện, thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của người bệnh đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho hoạt động Hội đồng người bệnh tại các khoa điều trị nội trú của Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân. Cấp khoa tổ chức hằng tuần; cấp bệnh viện tổ chức hằng tháng. Phòng Điều dưỡng phối hợp các khoa công bố lịch cụ thể và mời đại diện người bệnh phù hợp.

3. TRÁCH NHIỆM

Trưởng khoa hoặc người được phân công: tham dự, tiếp thu, giải đáp trong thẩm quyền và tổ chức xử lý kiến nghị tại khoa. Điều dưỡng trưởng khoa: chuẩn bị cuộc họp, mời người bệnh, hỗ trợ chọn Chủ tịch Hội đồng, ghi biên bản và theo dõi kiến nghị. Điều dưỡng, hộ sinh: hỗ trợ người bệnh tham gia hoặc chuyển ý kiến khi không thể dự họp.

Phòng Điều dưỡng: điều phối họp cấp bệnh viện, tổng hợp kiến nghị, chuyển đúng đầu mối, theo dõi và báo cáo. Ban Giám đốc: tiếp nhận vấn đề vượt thẩm quyền khoa, phân công đơn vị giải quyết. Bộ phận Quản lý chất lượng và các khoa, phòng liên quan: phối hợp xác minh, cải tiến và cung cấp kết quả xử lý.

4. KHÁI NIỆM/ CHỮ VIẾT TẮT

Hội đồng người bệnh là hình thức để người bệnh hoặc người đại diện đóng góp ý kiến về khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc và phục vụ. Chủ tịch Hội đồng là đại diện người bệnh được giới thiệu và được đa số người bệnh hoặc đại diện tham gia cuộc họp đồng ý; không mặc nhiên là cán bộ bệnh viện.

*** Từ viết tắt:**

- BS: Bác sĩ
- ĐD: Điều dưỡng
- BN: Bệnh nhân
- BYT: Bộ Y tế
- CT HĐNB: Chủ tịch hội đồng người bệnh
- KCB: Khám chữa bệnh
- QĐ: Quyết định

Căn cứ và nguyên tắc tổ chức

Căn cứ chính: Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997, Phần III Mục 10 về Hội đồng người bệnh; Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 về quyền, nghĩa vụ và bảo mật thông tin người bệnh. Khi phổ biến quyền, nghĩa vụ, sử dụng Luật hiện hành; không dùng Mục 8 Phần III của QĐ 1895 đã bị bãi bỏ.

Đối chiếu Thông tư 18/2024/TT-BYT ngày 01/10/2024: danh mục bãi bỏ không bao gồm Mục 10 Phần III. QĐ 1895 đã hết hiệu lực một phần, không dẫn toàn bộ Quy chế bệnh viện như văn bản còn nguyên hiệu lực. Tài liệu này là quy trình quản lý; QĐ 3023/QĐ-BYT áp dụng khi biên soạn quy trình kỹ thuật liên quan, không dùng để quy định lịch họp Hội đồng người bệnh.

Người bệnh có quyền tham gia hoặc gửi ý kiến qua người đại diện, nhân viên phụ trách hoặc kênh tiếp nhận khác. Không buộc người bệnh rời giường khi không phù hợp tình trạng sức khỏe; bố trí hỗ trợ giao tiếp khi cần. Tiếp nhận ý kiến khách quan, không gây bất lợi cho người góp ý; giữ riêng thông tin cá nhân và hồ sơ bệnh. Vấn đề cấp cứu, an toàn hoặc sự cố phải được báo và xử lý ngay, không chờ cuộc họp định kỳ.

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1.1 Lưu đồ họp hội đồng người bệnh cấp khoa

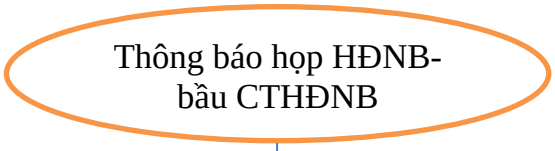
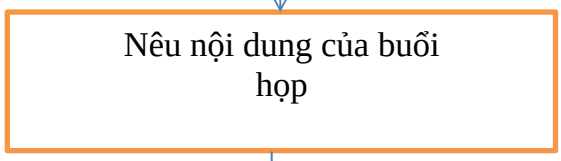
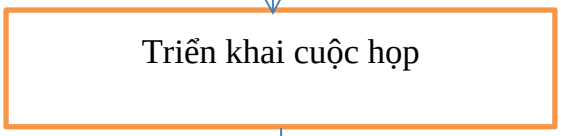
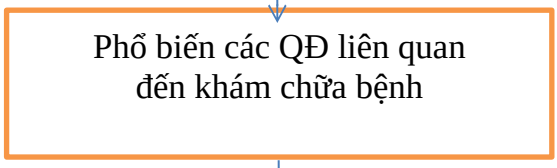
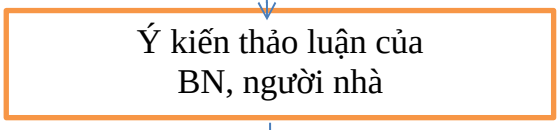
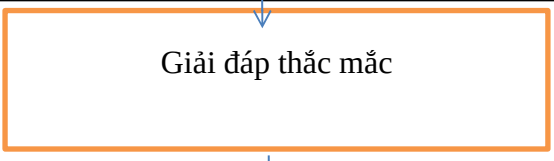
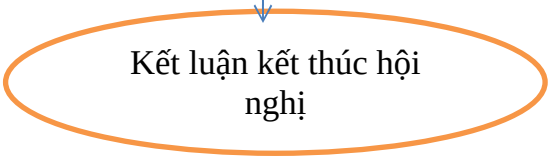
BƯỚC	TRÁCH NHIỆM	LƯU ĐỒ	GHI CHÚ
1.	ĐD Trưởng khoa	Thông báo họp HĐNB- bầu CTHĐNB	
2.	ĐD Trưởng khoa	Nêu nội dung của buổi Họp	
3.	Hội đồng NB	Triển khai cuộc họp	

4.	Lãnh đạo khoa-ĐD Trưởng khoa	Phổ biến các QĐ liên quan đến khám chữa bệnh	
5.	ĐD Trưởng khoa	Tư vấn GDSK	
6.	Hội đồng NB	Ý kiến thảo luận của BN, người nhà	
7.	Lãnh đạo khoa	Giải đáp thắc mắc	
8.	Chủ tịch HĐ,ĐD trưởng khoa	Kết luận kết thúc hội nghị	

5.1.2 Diễn giải lưu đồ

Bước	Trách nhiệm	Mô tả	Thời gian
Bước 1	ĐD trưởng khoa	Điều dưỡng trưởng khoa thông báo lịch họp hằng tuần, mời người bệnh hoặc đại diện phù hợp. Giới thiệu Chủ tịch Hội đồng và lấy ý kiến đồng ý của đa số người bệnh hoặc đại diện tham dự; ghi kết quả trong	Trước họp
Bước 2	ĐD trưởng khoa	Điều dưỡng trưởng khoa trao đổi chương trình với Chủ tịch Hội đồng, tổng hợp ý kiến gửi trước và kết quả xử lý kiến nghị kỳ trước; phân công thư ký.	Trong họp
Bước 3	Hội đồng NB	- Chủ tịch Hội đồng điều khiển và giới thiệu thành phần, mục tiêu cuộc họp.	Trong họp
Bước 4	Lãnh đạo khoa-ĐD trưởng khoa	Phổ biến nội quy, quyền và nghĩa vụ theo Luật hiện hành. Nội dung viện phí, bảo hiểm y tế do đơn vị phụ trách cung cấp hoặc phối hợp giải đáp; không cam kết vượt thẩm quyền. Thư ký ghi đầy đủ nội dung và ý kiến.	Trong họp
Bước 5	ĐD trưởng khoa	- Kết hợp công tác tư vấn giáo dục sức khỏe cho NB, người nhà NB về cách phát hiện, chăm sóc và phòng bệnh.	Trong họp
Bước 6	Hội đồng NB	- Các thành viên phát biểu ý kiến đóng góp cụ thể về hình thức tổ chức, quá trình khám chữa bệnh, chăm sóc phục vụ NB.. .tại bệnh viện	Trong họp
Bước 7	Lãnh đạo khoa	Trưởng khoa hoặc người được phân công tiếp thu, giải đáp trong thẩm quyền; giao đơn vị hoặc người xử lý và thời hạn phản hồi. Vấn đề cần xác minh ghi rõ chưa có kết luận. Kiến nghị vượt thẩm quyền được chuyển đúng đầu mối và theo dõi đến khi có kết quả.	Trong họp
Bước 8	Chủ tịch HĐ, ĐD trưởng	Chủ tịch Hội đồng tóm tắt; thư ký đọc lại nội dung, kiến nghị, phản hồi, người phụ trách và hạn xử lý để người tham dự xác nhận. Ký biên bản, gửi đơn vị liên quan và cập nhật sổ theo dõi; cuộc họp sau thông báo kết quả, không chỉ ghi nhận rồi kết thúc	Cuối họp và sau họp

5.2.1 Lưu đồ họp hội đồng người bệnh cấp bệnh viện

BƯỚC	TRÁCH NHIỆM	LƯU ĐỒ	GHI CHÚ
1.	Phòng điều dưỡng		
2.	Trưởng phòng điều dưỡng		
3.	Chủ tịch HĐ và lãnh đạo phòng ĐD		
4.	Lãnh đạo phòng ĐD		
5.	Lãnh đạo phòng ĐD		
6.	Hội đồng NB		
7.	Lãnh đạo BV		
8.	Chủ tịch HĐ, Phòng ĐD		

5.2.2 Diễn giải lưu đồ

Bước	Trách nhiệm	Mô tả	Thời gian
Bước 1	Phòng Điều dưỡng	Phòng Điều dưỡng thông báo lịch họp cấp bệnh viện hằng tháng; mời đại diện Hội đồng người bệnh các khoa và các đơn vị liên quan. Giới thiệu Chủ tịch Hội đồng và lấy ý kiến đồng ý của đa số người bệnh	Trước họp
Bước 2	Trưởng phòng ĐD	Trưởng phòng Điều dưỡng trao đổi chương trình với Chủ tịch Hội đồng, tổng hợp ý kiến gửi trước và kết quả xử lý kiến nghị kỳ trước; phân công thư ký.	Trong họp
Bước 3	Chủ tịch HĐ và Lãnh đạo Phòng ĐD	- Chủ tịch Hội đồng điều khiển và Lãnh đạo phòng ĐD giới thiệu thành phần, mục tiêu cuộc họp.	Trong họp
Bước 4	Lãnh đạo phòng ĐD	Phổ biến nội quy, quyền và nghĩa vụ theo Luật hiện hành. Nội dung viện phí, bảo hiểm y tế do đơn vị phụ trách cung cấp hoặc phối hợp giải đáp; không cam kết vượt thẩm quyền. Thư ký ghi đầy đủ nội dung và ý kiến.	Trong họp
Bước 5	Lãnh đạo phòng ĐD	- Kết hợp công tác tư vấn giáo dục sức khỏe cho NB, người nhà NB về cách phát hiện, chăm sóc và phòng bệnh.	Trong họp
Bước 6	Hội đồng NB	- Các thành viên phát biểu ý kiến đóng góp cụ thể về hình thức tổ chức, quá trình khám chữa bệnh, chăm sóc phục vụ NB...tại bệnh viện.	Trong họp
Bước 7	Lãnh đạo BV	Ban Giám đốc tiếp thu, giải đáp trong thẩm quyền; giao đơn vị hoặc người xử lý và thời hạn phản hồi. Vấn đề cần xác minh ghi rõ chưa có kết luận. Kiến nghị vượt thẩm quyền được chuyển đúng đầu mối và theo dõi đến khi có kết quả.	Trong họp
Bước 8	Chủ tịch HĐ, phòng ĐD	Chủ tịch Hội đồng tóm tắt; thư ký đọc lại nội dung, kiến nghị, phản hồi, người phụ trách và hạn xử lý để người tham dự xác nhận. Ký biên bản, gửi đơn vị liên quan và cập nhật sổ theo dõi; cuộc họp sau thông báo kết quả, không chỉ ghi nhận rồi kết thúc.	Cuối họp và sau họp

5.3 Theo dõi giải quyết kiến nghị sau họp

Mỗi kiến nghị có mã, nội dung, ngày nhận, mức ưu tiên, người hoặc đơn vị phụ trách, hạn phản hồi và trạng thái. Khoa xử lý trong thẩm quyền; vấn đề liên khoa hoặc vượt thẩm quyền chuyển Phòng Điều dưỡng và Ban Giám đốc. Khi chuyển, xác nhận người nhận, không coi việc gửi văn bản là đã giải quyết xong.

Thời hạn nội bộ đề xuất để bệnh viện phê duyệt: hoàn tất biên bản và chuyển kiến nghị trong 02 ngày làm việc; đầu mối nhận xác nhận và phản hồi ban đầu trong 05 ngày làm việc. Vụ việc cần thời gian thêm phải thông báo tiến độ, lý do và hạn dự kiến; quá hạn báo lãnh đạo phụ trách. Các mốc này không thay thời hạn pháp luật về khiếu nại, tố cáo hoặc báo cáo sự cố. Vấn đề đe dọa an toàn được xử lý ngay.

Chỉ đóng kiến nghị khi có kết quả hoặc giải thích có căn cứ, bằng chứng phản hồi cho người góp ý nếu liên hệ được và xác nhận của người phụ trách. Việc xác minh, khiếu nại, tố cáo và sự cố chuyên môn được chuyển quy trình riêng phù hợp; không kết luận trách nhiệm trong cuộc họp khi chưa xác minh.

5.4 Hồ sơ và kiểm tra

ĐDT lưu hồ sơ cấp khoa; Phòng Điều dưỡng lưu hồ sơ cấp bệnh viện và bảng theo dõi tổng hợp. Hồ sơ gồm lịch, danh sách tham dự, biên bản, kiến nghị, phân công và kết quả phản hồi; giới hạn truy cập theo nhiệm vụ. Thời hạn bảo quản theo danh mục bệnh viện phê duyệt. Đề xuất kiểm tra hằng tháng việc họp đúng lịch, đủ biên bản và kiến nghị quá hạn; tổng hợp cải tiến theo quý. Đây là tần suất quản trị đề xuất.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Đốc, ngày....tháng…năm 20...

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGƯỜI BỆNH CẤP BỆNH VIỆN

THỜI GIAN: Vào lúc...giờ, ngày.../.../ năm 20...

ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Bệnh viện

THÀNH PHẦN:

- Đại diện Ban giám đốc:.....
- Đại diện các khoa phòng:.....

Người bệnh hoặc đại diện tham dự: …… người; danh sách kèm theo. Kết quả thống nhất Chủ tịch: ……/…… người đồng ý.

Chủ tịch Hội đồng người bệnh chủ trì: ……

Thư ký cuộc họp:.....

NỘI DUNG:

1. Phổ biến nội quy quy định, quyền lợi và nghĩa vụ của NB, công tác khám chữa bệnh, công tác chăm sóc NB.. .....

2. Ý kiến thảo luận, đề xuất trong cuộc họp: .....

3. Giải đáp thắc mắc:.....

Kết quả giải quyết kiến nghị kỳ trước và nội dung còn tồn đọng: ……

Kiến nghị mới: nội dung — phản hồi — người/đơn vị phụ trách — hạn xử lý — mã theo dõi: ……

4. Kết luận và phân công xử lý kiến nghị: ……

Cuộc họp kết thúc lúc …… giờ …… phút, ngày ……/……/……

Chủ trì **TM. Phòng điều dưỡng** **Thư Ký**

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
KHOA…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Đốc, ngày...tháng…năm 20…

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGƯỜI BỆNH CẤP KHOA

THỜI GIAN: Vào lúc...giờ, ngày.../.../ năm 20...

ĐỊA ĐIỂM: PHÒNG ……..

THÀNH PHẦN:

- Đại khoa:.....
- Đại diện các phòng:.....

Người bệnh hoặc đại diện tham dự: …… người; danh sách kèm theo. Kết quả thống nhất Chủ tịch: ……/…… người đồng ý.

Chủ tịch Hội đồng người bệnh chủ trì: ……

Thư ký cuộc họp:.....

NỘI DUNG:

4. Phổ biến nội quy quy định, quyền lợi và nghĩa vụ của NB, công tác khám chữa bệnh, công tác chăm sóc NB.. .....

5. Ý kiến thảo luận, đề xuất trong cuộc họp: .....

6. Giải đáp thắc mắc:.....

Kết quả giải quyết kiến nghị kỳ trước và nội dung còn tồn đọng: ……

Kiến nghị mới: nội dung — phản hồi — người/đơn vị phụ trách — hạn xử lý — mã theo dõi: ……

4. Kết luận và phân công xử lý kiến nghị: ……

Cuộc họp kết thúc lúc …… giờ …… phút, ngày ……/……/……

Lãnh đạo khoa **Chủ trì** **Thư Ký**

Phụ lục Phiếu theo dõi giải quyết kiến nghị
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN — Khoa hoặc cấp bệnh viện: ……
Mã kiến nghị: …… Ngày nhận: …… Kỳ họp: ……
Nội dung kiến nghị: ……
Mức ưu tiên và hành động cần thực hiện ngay: ……
Người hoặc đơn vị phụ trách: …… Ngày xác nhận tiếp nhận: ……
Thời hạn phản hồi: …… Thời hạn giải quyết dự kiến: ……
Kết quả xác minh và xử lý: ……
Phản hồi cho người góp ý ngày: …… Hình thức: ……
Trạng thái: Mới nhận / Đang xử lý / Chờ xác minh / Quá hạn / Đã đóng
Nội dung còn chờ, lý do và hạn tiếp theo: ……
Bằng chứng kết quả và phản hồi: ……
Người xác nhận kết thúc: …… Ngày: …… Chữ ký: ……
Nguồn đối chiếu và điều kiện ban hành
QĐ 1895/1997/QĐ-BYT, Mục 10 Phần III: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=26135 ; TT18/2024/TT-BYT: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=170589 ; Luật 15/2023/QH15: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-15-2023-qh15-kham-benh-chua-benh-119231127164453959.htm . Rà soát ngày 13/10/2026.
Giữ tên người soạn, kiểm tra và phê duyệt theo bản nguồn; bệnh viện cần xác nhận phân công hiện tại. Chưa bổ sung chữ ký, số quyết định hoặc khẳng định bản cập nhật đã có hiệu lực. Trước ban hành, xác nhận lịch cụ thể, thành phần đại diện, địa danh trên biên bản, thời hạn phản hồi nội bộ, đầu mối và thời hạn bảo quản.